Établissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS D'URGENCE — ARTICLE R.4311-7 CSP

Anaphylaxie / Réaction allergique sévère

Adulte et enfant · auto-injecteur nominatif ou PAI : appliquer d'abord la dose prévue

URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT · toute suspicion d'anaphylaxie : **adrénaline ET 15 en même temps** (un collègue appelle) ; arrêt cardiaque : RCP + DSA.

J'applique si

- Atteinte **respiratoire** ou **circulatoire** brutale (dyspnée, stridor, hypotension, malaise) après un allergène.
- Ou **deux systèmes** atteints (peau, respiration, circulation, digestif) ; la peau peut être normale.

Je n'applique pas · je ne fais pas

- Réaction **cutanée isolée** : pas d'adrénaline → avis médical sans délai.
- Adrénaline **IV** : réservée à une équipe médicale entraînée.
- Lever ou faire marcher la personne.

J'agis

ACTES CONSERVATOIRES (R4311-7)

1. **Arrêter l'exposition** (perfusion, aliment, dard) ; renfort et **15**.

SUR CE PROTOCOLE D'URGENCE

2. **Adrénaline IM**, face antérolatérale de la cuisse (dose ci-contre, **1 mg/mL**) ; **répéter à 5 min** si besoin.

ACTES CONSERVATOIRES (R4311-7)

3. **Allongé, jambes surélevées** ; demi-assis si dyspnée ; PLS si inconscient ; grossesse : côté gauche.
4. **O2 masque haute concentration 15 L/min** si détresse ou SpO2 < 94 %.

SUR ORDRE DU 15

5. VVP et remplissage ; salbutamol nébulisé si bronchospasme ; antihistaminique, corticoïde.

Consigne orale du 15 ou du médecin → télé-prescription écrite, annexée au dossier.

Adrénaline 1 mg/mL, IM

Adulte, adolescent : **0,5 mg = 0,5 mL** (seringue 1 mL)

Enfant, < 50 kg : **0,01 mg/kg** (0,01 mL/kg), max 0,5 mg

- Auto-injecteur : dose du plan (150, 300 ou 500 µg)
- 2e dose à 5 min si les signes persistent

J'appelle le médecin

- Après l'épisode : bilan allergologique, prescription d'auto-injecteur, PAI.

Je surveille et je trace

- PA, FC, FR, SpO2, conscience, peau **toutes les 5 min** ; ne jamais laisser seul.
- **Réaction biphasique** possible : pas de maintien sur place sans décision du 15.
- Allergène, heure des signes, dose, site et heure de chaque injection.
- **Compte rendu écrit, daté, signé**, remis au médecin (R4311-7).

À retenir : L'adrénaline IM précoce est le traitement : antihistaminique et corticoïde ne la remplacent pas. Aucune contre-indication absolue en anaphylaxie.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Art. R4311-7 CSP ; RFE SFMU/SFA/GFRUP/SP2A anaphylaxie (2016) ; RCP Adrénaline Aguettant 1 mg/mL (ANSM, MAJ 17/08/2026), Anapen 300 (MAJ 18/09/2026), EpiPen 0,30 (MAJ 14/11/2025).

Réf. DOTR-IDE-ANA | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature